

Jak wspierać *bliskiego*

Karta dla rodziny i bliskich. Interwencja rodzinna redukuje nawroty o 50%. Komunikacja z niską krytyką i ciepłem — najsilniejszy modyfikowalny czynnik ochronny.

CZAS: 15 min Dla bliskich · do przeczytania razem

ŹRÓDŁO: Brown & Birley (1972, EE); Pharoah i in. (2010, Cochrane); Butzlaff & Hooley (1998)

JAK UŻYWAĆ

Zrozum trzy **składniki wysokiej EE** (sekcja 1), które podwajają ryzyko nawrotu. Naucz się **komunikacji bez krytyki** (sekcja 2) i **jak walidować emocje bez potwierdzania urojeń** (sekcja 3). W sekcji 4 — własna ocena i plan dla rodziny.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Pharoah i in. (2010, Cochrane meta-analiza 53 RCT): interwencje rodzinne **redukują nawroty** (NNT = 7 — leczyć 7 rodzin, by zapobiec 1 nawrotowi) i **hospitalizacje**. Butzlaff & Hooley (1998, meta-analiza 27 badań): wysoka *expressed emotion* w domu — krytycyzm, wrogość, nadmierne zaangażowanie — **podwaja ryzyko nawrotu**. EE nie jest „winą rodziny” — to **naturalna reakcja** na trudną sytuację, którą można zmienić. NICE (2014) rekomenduje interwencję rodzinną dla *każdej* osoby z psychozą mieszkającej z rodziną.

01 📖 Trzy składniki wysokiej EE

Wysoka EE (ang. *expressed emotion*) to atmosfera emocjonalna w domu mierzona w trzech wymiarach. **Każdy z nich jest niezależny** — można mieć wysoki krytycyzm bez wrogości, lub odwrotnie.

KRYTYCYZM

Częste uwagi: „*znowu leżysz*”, „*czemu nigdy*”, „*nie potrafiś*”. Liczba krytycznych komentarzy na godzinę — najsilniejszy predyktor nawrotu.

WROGOŚĆ

Krytyka idąca w stronę *osoby*, nie zachowania. „*Jesteś leniem*” zamiast „*chciałbym, żebyś dziś wyszedł na spacer*”. Atak na tożsamość.

NADMIERNE ZAANGAŻOWANIE

Brak granic, kontrolowanie życia chorego, poświęcanie się ponad miarę, dramatyzacja. Też podnosi ryzyko — przeciwieństwo wsparcia.

02 🔗 Komunikacja bez wysokiej EE — pięć zasad

1 · BEZ KRYTYKI, Z CIEPŁEM

Zamiast „*znowu leżysz!*” → „*widzę, że dziś jest ci trudno*”. Pokazanie zauważenia, nie ocena.

2 · MAŁE, JASNE PROŚBY

Zamiast „*weź się w garść*” → „*czy mógłbyś dziś wyjść ze mną na 10 minut?*”. Konkretne, wykonalne, z towarzyszem.

3 · DOCENIANIE WYSIŁKU

Każdy mikrokrok — zauważ. „*Dziękuję, że wstałeś dziś rano*”. Stosunek 5:1 — pięć docenień na jedno trudne wymaganie.

4 · BEZ SARKAZMU I IRONII

Trudne do zrozumienia w psychozie. Mów *wprost*, krótko, spokojnie. Sarkazm bywa odebrany dosłownie i bolesnie.

5 · WYBIERZ, KIEDY ROZMAWIAĆ O TRUDNYCH SPRAWACH

Nie w trakcie nasilenia objawów. Nie wieczorem przed snem. Krótko, raz w tygodniu — wspólne planowanie, przeglądanie. Reszta — codzienna, normalna rozmowa.

03 Reagowanie na urojenia i halucynacje

Złota zasada: waliduj *emocję*, nie potwierdzaj *treści*. Bliski mówi, że sąsiad go truje — nie mów „tak, faktycznie” (nieprawda) ani „to bzdura” (zerwanie zaufania). Powiedz: „widzę, że się boisz. To musi być przerażające. Jak mogę Ci pomóc?”.

CZEGO NIE ROBIĆ

- Konfrontować: „to nieprawda!”
- Przytakiwać: „tak, faktycznie sąsiad cię truje”
- Wyśmiewać, bagatelizować
- Argumentować logicznie z urojeniem
- Mówić: „weź lek i przestań”

CO DZIAŁA

- Walidować emocję: „widzę, że się boisz”
- Pytać: „czego potrzebujesz, żeby było ci bezpieczniej?”
- Być spokojnie obecnym
- Pomóc skontaktować się z psychiatrą
- Zauważać, gdy wraca stabilność

04 Plan dla naszej rodziny

CO CHCĘ ZMIENIĆ W MOJEJ KOMUNIKACJI

— jedna konkretna rzecz na ten tydzień

JAK ZADBAM O SIEBIE

— grupa wsparcia, własna terapia, przerwy

Klucz: nie możesz wyleczyć bliskiego z psychozy — to nie jest w Twojej mocy. **Możesz stworzyć środowisko**, w którym zdrowienie jest łatwiejsze: niska krytyka, ciepło, jasne małe prośby, walidacja emocji. Butzlaff & Hooley (1998): w rodzinach z niską EE ryzyko nawrotu jest o *połowę niższe* przy tej samej farmakoterapii. **I zadbaj o siebie** — wypalenie opiekuna jest realne i pogarsza wszystko. Grupy wsparcia dla rodzin, własna terapia, przerwy — nie luksusy, lecz konieczność. Polska: stowarzyszenie „Rodzin Osób Chorych Psychiczenie”, grupy przy CZP, fundacje regionalne.